

הפלות

הפלה היא סיום ההיריון לפני שהעובר מסוגל לחיות בכוחות עצמו מחוץ לרחם (לפני שבוע 20 להיריון) או כאשר מסת העובר היא מתחת ל-500 גרם.

הפלות עצמוניות (טבעיות)

- שכיחות ההפלות הטבעיות היא כ-15% מכלל ההריונות.
- ככל שעולה גיל האם - עולה גם שכיחות ההפלות.
- כ-80% מההפלות מתרחשות עד לשבוע ה-12 (הפלה מוקדמת). היתר בין השבועות 13-20 (הפלה מאוחרת).

תהליך ההפלה וסיבותיה

- הביצית המופרית מתנתקת מקיר הרחם.
- התנתקות הביצית כמעט תמיד גורמת לדימום (וזו בדרכ כלל הסיבה שמזמינים אמבולנס).
- הדימום יכול להיות דקיק או שוטף ומלווה בכאב בטן.
- הסיבה להפלה יכולה להיות נעוצה בעובר או באם או ברחם עצמו:

גורמים עובריים

- אנומליות עובריות כמו הפרעה במבנה הגנטי. בכ-80% מכלל ההפלות יש מום בעובר.

גורמים הקשורים לאם

- גורמים זיהומיים - בקטריאליים (דלקת ריאות, כליות), ויראליים (אדמת, הרפס)
- מחלות מטבוליות - סוכרת, היפרתירואידיזם
- מחלות כרוניות - קרדיוסקולרית, לחץ דם
- הפרעות הורמונליות - אי-ספיקת הגופיף הצהוב (פרוגסטרון)
- הפרעות תזונתיות - חסר בחלבונים, מחסור בוויטמינים
- בעיות אימונוולוגיות - נוגדנים הפועלים על העובר
- טראומה ישירה לרחם
- הקרנות
- תרופות (משלשלים, עופרת ועוד)
- מתח נפשי

הפרעות רחמיות

- השרשה של ההיריון באזורים שיש בהם מחזור דם מופחת בדופן הרחם (מומים רחמיים מולדים חד או דו־קרני, רחם כפול או מחולק על ידי מחיצה)
- שרירים תת־ריריים
- הידבקות תוך־רחמיות
- אי־ספיקה צווארית - הפלה מאוחרת או לידה מוקדמת

סוגי הפלות

הפלה צפויה או מאיימת (threatened abortion) - כאשר מופיע דםם קל מן הרחם מפנים לטיפול בבית החולים. הטיפול כולל הסבר על המצב, השגחה ועידוד.

הפלה בלתי נמנעת (inevitable abortion) - הפלה שבה הדימום בולט, מלווה בכאבים ובפתיחה של צוואר הרחם. לעיתים מתלווה ירידת מי שפיר או בליטה של קרומי העובר דרך צוואר הרחם.

הפלה לא שלמה (incomplete abortion) - כאשר העובר והשליה נפלטים בחלקם מן הרחם. בהפלות לפני השבוע ה־14 מבצעים גרידה בבית החולים. אחרי 14 שבועות נותנים תרופות לזירוז הצירים ולהתרוקנות הרחם.

הפלה שלמה (complete abortion) - כאשר העובר והשליה נפלטים מהרחם בשלמותם. בדרך כלל נחשבת ההפלה להפלה לא שלמה מחמת הספק כאשר האישה מופיעה זמן רב לאחר ההפלה, ללא תלונות. במקרה זה בודקים אם הרחם בגודל טבעי, אם צוואר הרחם סגור, אם הדימום פסק, ומוודאים באולטרסאונד כי הרחם ריק. מקרים אלו אינם דורשים גרידה.

הפלה נידחית, בוששת (missed abortion) - כאשר העובר מת והרחם שומר את תוכנו. בבדיקת אולטרסאונד נצפה שאין דופק עוברי, הרחם קטן מגיל ההיריון ויש דימום קל. אם העובר המת נשאר ברחם מעל שבועיים יש סיכון ל־DIC, קרישה תוך־כלית (disseminated intravascular coagulation: DIC), לכן דואגים בבית החולים לרוקן את תוכן הרחם.

הפלה מזהמת, אלוחה (septic abortion) - כאשר ההפלה מלווה בחום ובסימנים של זיהום תוך־בטני. הגורמים יכולים להיות חיידקים מזנים שונים. הזיהום יכול להתפשט לכל הבטן ועלול לגרום לפריטוניטיס (דלקת הצפק, peritonitis). יש סיכון להיווצרות קרישי דם עם אפשרות לתסחיפים לריאות. סיבוכים נוספים: הלם ספטי, אי־ספיקת כליות ו־DIC. הטיפול בבית החולים כולל אנטיביוטיקה מסיבית, עירוים תוך־ורידים לתיקון תת־נפח. ההפלה תתבצע רק לאחר ייצוב המודינמי של המטופלת. אם לא מצליחים להשתלט על הזיהום שוקלים כריתת הרחם.

הפלה חוזרת (habitual abortion) - נשים המפילות שלוש או יותר פעמים רצופות. הסיבות כוללות את כל האפשרויות שהוצגו קודם לכן. במקרים אלו עושים בירור יסודי שכולל את כל הבדיקות: סוכרת, יתר לחץ דם (יל"ד), אימונולוגיה וזיהומים, כולל התאמה גנטית. הטיפול ייקבע לפי ממצאי הבדיקות.

הפלה מלאכותית (induced abortion) - הפסקה יזומה של ההיריון. ההחלטה ניתנת על ידי ועדה הפועלת על פי החוק ומורכבת מצוות רב־תחומי ומקבלת החלטות על פי קריטריונים מוגדרים.

הטיפול בהפלה

אישה המתלוננת על כאבי בטן ודימום וגינאלי תטופל כמו שמתפלים בהלם, גם אם אין סימנים לכך בבדיקה ראשונית.

- מתחילים פינוי לבית חולים ומודיעים על האבחנה החשודה תוך כדי הנסיעה
- אבטחת A, B ומתן חמצן דרך מסכה
- משכיבים את המטופלת, רצוי על צידה השמאלי
- משיגים גישה ורידית ומתן נוזלים לפי הפרוטוקול
- אין לתת דבר דרך הפה
- יש להתכונן למתן טיפול תרופתי להקאות
- שומרים על חום גוף
- עוקבים אחר סימנים חיוניים לאורך כל הטיפול והפינוי
- יש לשקול חבירה לנט"ן בתיאום עם מוקד מרחבי

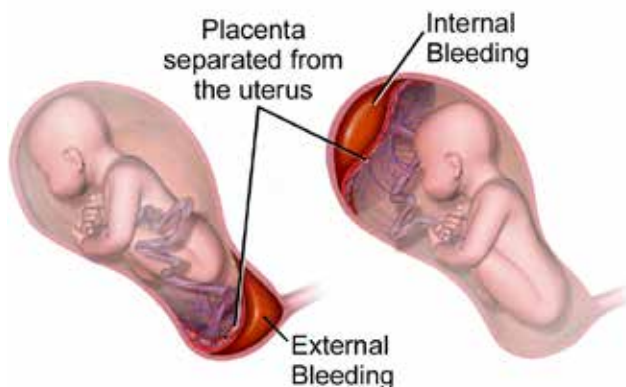
דימומים בטרומסטור השלישי

דימום מהנרתיק הוא סימן מבשר רעות בכל שלבי ההיריון, אבל הוא מדאיג במיוחד כשהוא קורה בטרומסטור השלישי בגלל הסכנה שבחוסר דם (הלם, ירידה בהספקת חמצן לעובר) בשלב זה של ההיריון.

ארבעת הגורמים העיקריים לדימום בטרומסטור השלישי

(1) ניתוק פתאומי של השליה (Placental Abruption)

- בדרך כלל קורה לנשים שסבלו מיתר לחץ דם בהיריון. אופייני לנשים שעברו הריונות רבים. התלונות: דימום כהה, כאב בטן פתאומי וחוסר תזוזת העובר. בבדיקה: ייתכנו סימני הלם, בטן רגישה, אין קולות לב לעובר (תמונה 16.13).



איור 16.13 ניתוק של השליה

היפרדות השליה מדופן הרחם והצטברות דם עקב קרע של כלי דם שלייתיים.

(מזכה: BruceBlaus, Own work, CC BY 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30462651>)